

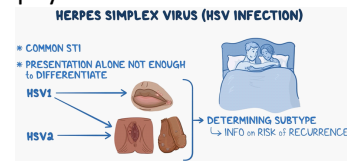
HERPES GENITAL ET GROSSESSE

I. Introduction - définition

- Herpès simplex virus: Infection sexuellement transmissible la plus fréquente dans les pays industrialisés
- Prévenir la transmission materno-fœtale chez la femme enceinte

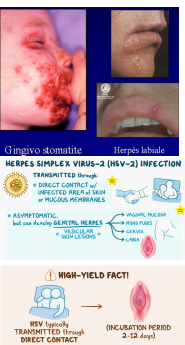
II. Epidémiologie

- **Herpès maternel:**
 - Séroprévalence des virus herpétiques chez les femmes enceintes américaines en 2007:
 - 63% pour HSV-1
 - 22% pour HSV-2
- **Herpès néonatal** : Transmission 1/3000 accouchements
- Incidence global de l'herpès néonatale est de 5 à 80 pour 100 000 naissances vivantes
- Le groupe ethnique et le nombre de partenaires sexuels apparaissent comme étant les meilleurs facteurs prédictifs du statut sérologique HSV aux USA chez les femmes enceintes
- Le taux estimé de séroconversion HSV-1 et/ou HSV-2 durant la grossesse est de 2,1%
- **Facteurs de risque:**
 - ❖ Mère présentant un premier épisode symptomatique proche du terme
 - ❖ Mère de jeune âge
 - ❖ Accouchement avant 38SA
 - ❖ HSV isolé au niveau cervical
 - ❖ HSV-1 présent au moment du travail



III. Pouvoir pathogène et transmission materno-fœtale

- HSV-1 et HSV-2
- Le risque d'acquisition d'HSV pour la mère apparaît uniforme tout au long de la grossesse
- 30% des infections surviennent au premier trimestre de la grossesse
- 30% au second trimestre de la grossesse
- 40% au troisième trimestre de la grossesse
- **Virus type 1:** Responsable de la majorité des herpès situés au-dessus de la taille, il correspond généralement à l'herpès labial, l'herpès peut aussi se développer sur d'autres parties du visage: yeux, nez, menton
- **Virus type 2:** Responsable le plus souvent de l'herpès génital qui touche les organes sexuels, il peut également se développer sur les fesses et les cuisses
- Le risque de transmission materno-fœtale d'une mère nouvellement infectée proche de l'accouchement est élevé: 30% à 75%
- Ce risque est lié à l'absence ou l'insuffisance de l'immunité humorale spécifique développée par la femme enceinte en cas d'infection proche du terme
- Lorsque l'infection est acquise avant le troisième trimestre ou qu'une récurrence survient à terme: le risque est faible
- **Transmission de contact:**
 - Contact direct lors du passage dans la filière génitale ou de façon indirecte ascendante lorsque la poche des eaux est rompue
 - Le risque de transmission augmente avec la durée de d'expulsion, l'ouverture prolongée de la PDE, la pose d'électrode de scalp, la sévérité des lésions maternelles et le faible titre d'AC maternels
 - Cette contamination per-partum concerne le plus souvent l'HSV 2
- **Transmission verticale:**
 - La transmission trans-placentaire, lors d'une primo-infection avec virémie maternelle est rare mais responsable d'infection congénitale grave



HERPES SIMPLEX VIRUS-2 (HSV-2) INFECTION

TRANSMITTED through DIRECT CONTACT with INFECTED FLUID or SORE or MUCOUS MEMBRANES

ASYMPTOMATIC, but can develop GENITAL HERPES (vesicular or pustular lesions)

PRIMARY OUTBREAK (INCUBATION PERIOD 2-12 days)

NEW lesions TRANSMITTED through DIRECT CONTACT

RECURRENT INFECTIONS can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

MICROCEPHALY

SKIN LESIONS

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

SIGNIFICANTLY ↑ RISK for NEONATAL TRANSMISSION

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

RECURRENT INFECTIONS

can also be TRANSMITTED to NEONATE during DELIVERY through INTRAPARTUM EXPOSURE to VIRUS

disseminated disease

CNS disease

long-term neurologic impact

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV INFECTION)

PRIMARY OUTBREAK

NEONATAL CHORIORETINITIS

IV. Diagnostic positif

- Herpès génital maternel: Fréquence, durée et sévérité des récurrences symptomatiques s'accroissent pendant la grossesse
- Des cas d'affection maternelle sévère ont été rapportés: encéphalite herpétique, hépatite herpétique
- **Comment reconnaître une poussée de l'herpès?**
 - Elle commence par des démangeaisons, des brûlures, des picotements au niveau des zones infectées, suivis quelques heures ou jours après par une rougeur, des petites croûtes, la cicatrisation intervient au bout d'une dizaine de jours

Chez la mère:

- Sérologie spécifiques
- Culture et PCR

Chez le fœtus:

- Culture virale sur prélèvement
- Anomalies de l'imagerie cérébrale
- Anomalies de l'électro-encéphalogramme

Les facteurs associés à un risque majoré d'herpès néonatal:

- ❖ L'expression clinique
- ❖ La présence d'HSV à l'accouchement
- ❖ Le sérotype viral 1 isolé
- ❖ La primo-infection
- ❖ L'accouchement par voie basse
- ❖ La mise en œuvre de gestes invasifs
- ❖ La prématurité
- ❖ L'hyperthermie pendant le travail
- ❖ La rupture prématurée des membranes

V. Conséquences fœtales et néonatales

- **Primo-infection:**
 - Survenant au T1 ou T2 peut être à l'origine d'avortement ou de prématurité ou de retard de croissance intra-utérin
 - Le risque d'infection néonatale est plus important en cas de primo-infection survenant au T3
- **Récurrence herpétique:**
 - En cas de lésion herpétique génitale présente dans la semaine précédent l'accouchement ou au moment du franchissement de la filière génitale maternelle, le risque infectieux est de 2% à 8%

Herpès congénital:

- Microcéphalie, anencéphalie, microphthalmie, calcifications intra-craniennes, chorio-rétinite, hépatosplénomégalie

Herpès néonatale:

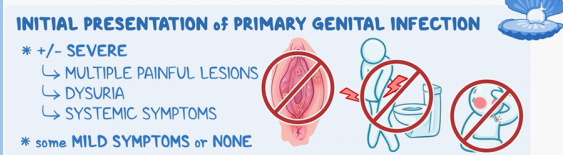
- Formes systémiques ou disséminées
- Méningo-encéphalites
- Formes localisées: Peau, œil, bouche
- Formes asymptomatiques

Les facteurs péjoratifs associés à un risque de mortalité élevée sont:

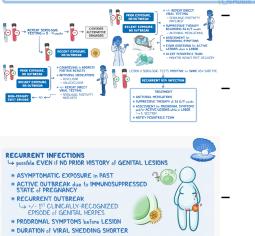
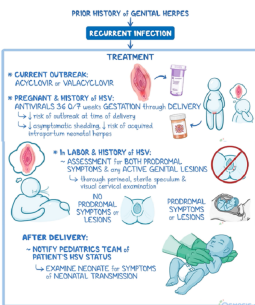
- L'existence d'une forme neurologique ou disséminée
- Troubles de la conscience
- Atteinte pulmonaire
- Coagulopathie intra-vasculaire disséminée
- Prématurité

VI. Prise en charge thérapeutique

- **Primo-infection herpétique maternelle:**
 - Traitement anti-viral curatif au moment de l'épisode et pendant 10j
 - Si acquisition de l'HSV en toute fin de grossesse:
 - Aciclovir depuis l'infection jusqu'au terme
 - Césarienne programmée



- **Césarienne recommandée en cas de:**
 - Primo-infection survenant à moins de 1mois avant la date prévue de l'accouchement
 - La présence de lésions actives au moment de l'accouchement avant rupture des membranes ou rupture de moins de 6H
- **Recommandations Françaises: en cas de PI**
 - Traitement par Aciclovir prescrit
 - Traitement à prolonger jusqu'au terme si l'épisode survient en fin de grossesse, dans le cas contraire, l'Aciclovir doit être repris à partir de 36SA jusqu'à terme de la grossesse
 - La césarienne n'est indiquée qu'en cas de lésions actives avec poche des eaux intactes ou rompue depuis moins de 4H
- **Récurrence herpétique maternelle:**



- L'administration d'un traitement antiviral supprimeur à partir de 36SA a prouvé son efficacité en termes de réduction du risque d'excrétion virale, de lésions cliniques et du recours à la césarienne en cours de travail
 - Aciclovir 400mg X 3/j
 - Aciclovir 200mg X4/j
 - Durée du traitement s'étend de 36SA jusqu'à l'accouchement
- Devant la rupture des membranes, la césarienne doit idéalement intervenir dans les 4 à 6H suivant cette rupture
- La présence de lésions récurrentes survenant ailleurs que dans l'aire génitale ne contre indique pas l'accouchement par voie basse
- Lorsque la patiente ne présente aucune lésion ni prodrome alors qu'elle est connu pour des récurrences herpétiques génitales, l'accouchement par voie basse doit être accompagné de mesure de sécurité
 - Prélèvements locaux systématiques, badigeonnage vaginal à la polyvidone iodée toutes les 2heures pendant le travail, éviction des manœuvres invasives, désinfection du cordon à la bétadine, bain bétadiné du nouveau-né, administration d'un collyre à l'Aciclovir
 - En cas de rupture des membranes chez une femme souffrant de récurrences, la poursuite de la grossesse et la corticothérapie sont à envisager
 - **L'accouchement par voie basse est accepter en cas de:**
 - Récurrence datant de plus de 7j ou sans lésion cervico-vaginale à l'accouchement
 - Primo-infection ou infection initiale remontant à plus de 3semaines sans récurrence cervico-vaginale
 - Primo-infection traitée supérieure à 10j sans récurrence
 - **Dans le post-partum:**
 - Mère:
 - Si Lésion herpétique: précaution d'hygiène
 - L'allaitement maternel n'est contre indiqué qu'en cas de lésions herpétiques actives mammaires ou mamelonnaires jusqu'à la guérison
 - Nouveau-né:
 - Traitement antiviral Aciclovir par voie veineuse doit être débiter le plus tôt possible
 - Prélèvements systématiques pour détecter toute infection à HSV avant expression clinique: conjonctives, bouche, pharynx, peau, urines, LCR
 - Si herpès néonatal:
 - Aciclovir: 20mg/kg /8h par voie intra-veineuse durant 14j en cas de forme localisée et 21j en cas de forme disséminée ou avec atteinte neurologique
 - Indications du traitement néonatal:
 - Positivité des cultures virales néonatales
 - Eruption suspecte d'herpès, troubles neurologiques
 - Primo-infection maternelle à l'accouchement ou dans le mois le précédant quelle que soit la voie de l'accouchement
 - Césarienne après 4h de rupture de la poche des eaux en cas d'herpès maternelle
 - Naissance par voie basse dans un contexte de récurrence herpétique dans le dernier mois avec facteurs de risque associés
 - Le délai de prise en charge et d'instauration du traitement de l'herpès néonatal conditionne le pronostic neurologique

- La surveillance clinique et virologique doit être soutenue pendant un mois

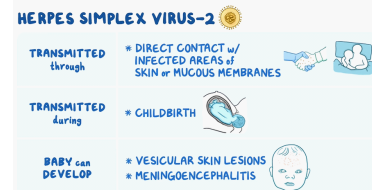
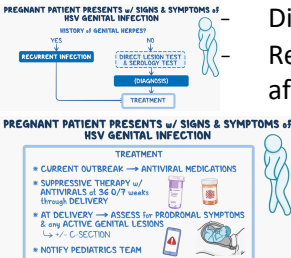
VII. Prévention : QE ++

- ✓ Dépistage des femmes et des couples séro-discordants
- ✓ Traitement antiviral chez l'homme
- ✓ Topiques génitaux: Crème Interferon α
- ✓ Vaccination des femmes à risque: vaccin à l'étude
- ✓ Anticorps monoclonaux
- ✓ Immuno-modulateurs

VIII. Conclusion

Difficultés diagnostiques et thérapeutiques

Recherche exploite de nouvelles pistes diagnostiques et thérapeutiques, contournant ces difficultés afin d'optimiser encore la prise en charge



Herpès génital pendant la grossesse

